

Venere — Guida di qualifica dei target (centri estetici da convertire in ambulatorio)

Le domande da fare a ciascuno dei ~116 target per capire se è convertibile in ambulatorio. Riservato.

AGGIORNAMENTO (settembre 2026). Il regime target è l'**ambulatorio** (in Lombardia i trattamenti core, iniettivi e laser medicali, lo richiedono), non il semplice studio medico. Quindi la barra sull'immobile è più alta: ~90-120 mq, **locali distinti** (attesa + 2+ sale + servizi accessibili + percorsi pulito/sporco + sterilizzazione), meglio **indipendente/non condominiale**. Vedi `Venere_Protocollo_Verifica_Target.md`.

Come si usa

Il target NON è la clinica medica (contesa dai fondi): è il **centro estetico convertibile**. Un centro è "in target" se ha **tre cose insieme**: (1) un **immobile autorizzabile** ad ambulatorio, (2) una **base clienti reale e fedele all'insegna**, (3) un **titolare disposto a vendere e restare**. Le domande sotto servono a verificarle, in 3 passaggi per **fonte**: prima quello che scopri **da solo** (senza contatto), poi quello che chiedi al **titolare**, infine quello che verifichi **sul posto**. Chiudi con la **scorecard GO/NO-GO**.

Regola d'oro dell'approccio: al primo contatto NON metti numeri sul tavolo e non spaventi. Molte di queste domande si fanno come "scambio sul futuro del settore", non come interrogatorio. La convertibilità dell'immobile la pre-verifichi tu, non gliela chiedi.

Blocco A — Pre-screen (senza contatto, da desk)

Scarta qui la maggior parte dei 116 prima di disturbare chi non è convertibile.

- Destinazione d'uso dell'immobile.** Buona notizia per Milano: nel **Tessuto Urbano Consolidato** (quasi tutta la città) vale l'**indifferenza funzionale** (PGT, Piano delle Regole art. 8) e il **mutamento d'uso senza opere è sempre ammesso e gratuito**. Quindi a Milano il vincolo urbanistico **raramente è un NO-GO**: la funzione sanitaria è ammessa dove c'è quella commerciale. Il gate vero diventa **fisico/ATS** (punto 2 e Blocco C): riesci a ricavare una **sala medica a norma**? (Eccezioni da verificare con un tecnico + visura: tutele del commercio al piano terra in certe vie, edifici storici/vincolati, regolamenti condominiali. La categoria catastale — C/1 negozio, A/10 studio/gabinetto medico — è fiscale, non blocca.)
- Superficie e layout** (mq dall'annuncio/foto): c'è spazio per **2+ sale** (di cui una medica), sala d'attesa, servizi igienici? Sotto una certa dimensione non ci fai un ambulatorio.
- Zona e bacino**: reddito, passaggio, densità (Centro/Brera, CityLife-Fiera, Navigli, hinterland pregiato). Fuori bacino = ticket e volumi bassi.
- Anni di attività e reputazione**: da quanto esiste? Recensioni (Google, social): quante, che voto, che tono? Vecchio + ben recensito = base clienti fedele.
- Servizi offerti** (sito/social/listino): fanno già trattamenti "vicini" al medico (peeling, radiofrequenza, laser, luce pulsata)? Clientela abituata = upsell più facile.
- Segnali di vendita**: è in annuncio? Da quanto? Età presunta del titolare (uscita generazionale)?

Blocco B — Domande al titolare (primo colloquio)

Ascolta l'80%. Inquadra come confronto tra operatori, non come due diligence.

B1. Economics (con tatto)

7. **Fatturato annuo** e **andamento** ultimi 2-3 anni (cresce, stabile, cala)?
8. **Ticket medio** e **frequenza** di visita del cliente tipo?
9. Quanto del giro passa da **POS/fattura** e quanto in **contanti**? *(la domanda sul nero: chiedila indirettamente, "come gestisci gli incassi", e leggi la reazione — vedi Blocco D nero)*
10. Ci sono **debiti, contenziosi, contratti onerosi** (leasing macchinari, affitto)?

B2. Clientela (il vero asset)

11. **Quanti clienti attivi** (ultimi 12 mesi)? C'è un **database/CRM**?
12. I clienti sono fedeli **all'insegna/al centro** o a **una persona specifica**? → se seguono una singola estetista che potrebbe andarsene, l'asset è fragile.
13. **Fascia d'età e spesa** della clientela? Chiedono già **botox/filler/medicina estetica** (che oggi non puoi offrire)? → domanda già latente = conversione facile.
14. Quanti **nuovi clienti** al mese e da dove arrivano (passaparola, social, passaggio)?

B3. Servizi, staff, apparecchiature

15. **Mix di servizi** e quali generano più margine?
16. Quali **apparecchiature** (laser, IPL, radiofrequenza, ecc.) e di che anno?
17. Quante **estetiste**, da quanto lavorano, **resterebbero** dopo un cambio?
18. C'è **già un medico** che collabora a volte (molti centri hanno un medico esterno per alcune prestazioni)?

B4. Immobile e autorizzazioni

19. L'immobile è **di proprietà o in affitto**? Durata/rinnovo del contratto?
20. C'è **spazio (o stanze inutilizzate)** per aggiungere una **sala medica** con sterilizzazione?
21. Ha **mai avuto autorizzazioni sanitarie** o un medico autorizzato in sede?

B5. Motivazione e disponibilità (il make-or-break del deal)

22. **Perché** venderebbe/aprirebbe a un partner? (pensione, stanchezza burocrazia, voglia di crescere)
23. **Tempistica**: quanto è pronto a muoversi?
24. Sarebbe disposto a **restare 24-36 mesi** e a **reinvestire parte del prezzo in equity** (rollover)? → la disponibilità al rollover è **il segnale più forte** di allineamento.
25. Che **aspettative di prezzo** ha (se esce da solo)?

Blocco C — Verifica sul posto (sopralluogo / DD leggera)

Solo sui target che passano A e B.

26. **Layout reale**: si ricava una sala medica a norma? Servizi igienici **accessibili**? Spazio per **sterilizzazione** e gestione rifiuti sanitari?
27. **Stato dell'immobile e impianti**: quanto capex servirebbe per portarlo a requisito?

28. **Qualità gestionale:** c'è un gestionale/agenda? Libri e incassi ordinati? POS effettivamente usato?

29. **Affluenza reale** osservata vs dichiarata.

Blocco D — I paletti che dicono NO-GO (red flags)

- **Immobile non convertibile** (destinazione d'uso vincolata, spazi insufficienti). → il n°1.
- **Clientela legata a una singola persona** che se ne va con i clienti.
- **Micro-salon** senza vera base clienti (2 cabine, pochi passaggi): niente da convertire, e comunque troppo piccolo per un ambulatorio.
- **Titolare che pretende credito per il nero** non dimostrabile, o rifiuta il "periodo bianco".
- **Reputazione compromessa** / contenziosi / autorizzazioni fuori regola.
- **Titolare che non vuole restare** né rollare equity (per le sedi dove serve continuità).

Sul nero: non prometti mai di preservarlo. Se il titolare pretende di essere pagato sul sommerso, spiega la leva del rollover (reddito → capital gain) e proponi il periodo bianco pre-acquisizione per prezzare sul reale dimostrato.

Blocco E — Le 10 domande "killer" (versione corta)

Se hai poco tempo, queste dieci separano il target dal non-target: 1. L'immobile ha destinazione d'uso **convertibile** ad ambulatorio? (*pre-verifica tu*) 2. C'è **spazio per una sala medica** a norma? 3. Quanti **clienti attivi** hai e sono fedeli **al centro** (non a una persona)? 4. I clienti chiedono già **medicina estetica**? 5. **Fatturato** e trend degli ultimi 3 anni? 6. Quanto passa da **fattura/POS**? 7. Quante **estetiste** e **resterebbero**? 8. Immobile **di proprietà o affitto** (e durata)? 9. **Perché** venderesti e **quando**? 10. Resteresti **24-36 mesi** e **reinvestiresti in equity**?

Come si traduce in punteggio (scorecard)

Ogni target riceve un voto 1-5 su 7 criteri pesati (vedi file [Venere_Scorecard_116_Target.xlsx](#)):

Criterio	Peso	Cosa misura
Convertibilità immobile	25%	destinazione d'uso + spazi + requisiti (il gate)
Base clienti	20%	dimensione + fedeltà al brand
Mix servizi injectables-amenable	10%	quanto è vicina la clientela al medico
Bacino / location	10%	reddito, passaggio
Economics e verificabilità	15%	fatturato/margine + qualità libri (anti-nero)
Motivazione titolare	15%	vende, permanenza, rollover
Reputazione / compliance	5%	recensioni, zero baggage

Totale pesato → **priorità:** A (≥4), B (3-4), C (<3). I target **A** sono quelli con cui aprire la trattativa; i **B** si coltivano; i **C** si scartano. Obiettivo del funnel: dai **116** ai **~5 venditori pronti** ai **3 closing**.